

社会医学基礎(公衆衛生学)コース: 地域保健・地域医療(3) 健康危機管理(感染症・災害)

名古屋市保健所中川保健センター

細野晃弘
(H14名市大卒)

COI:なし

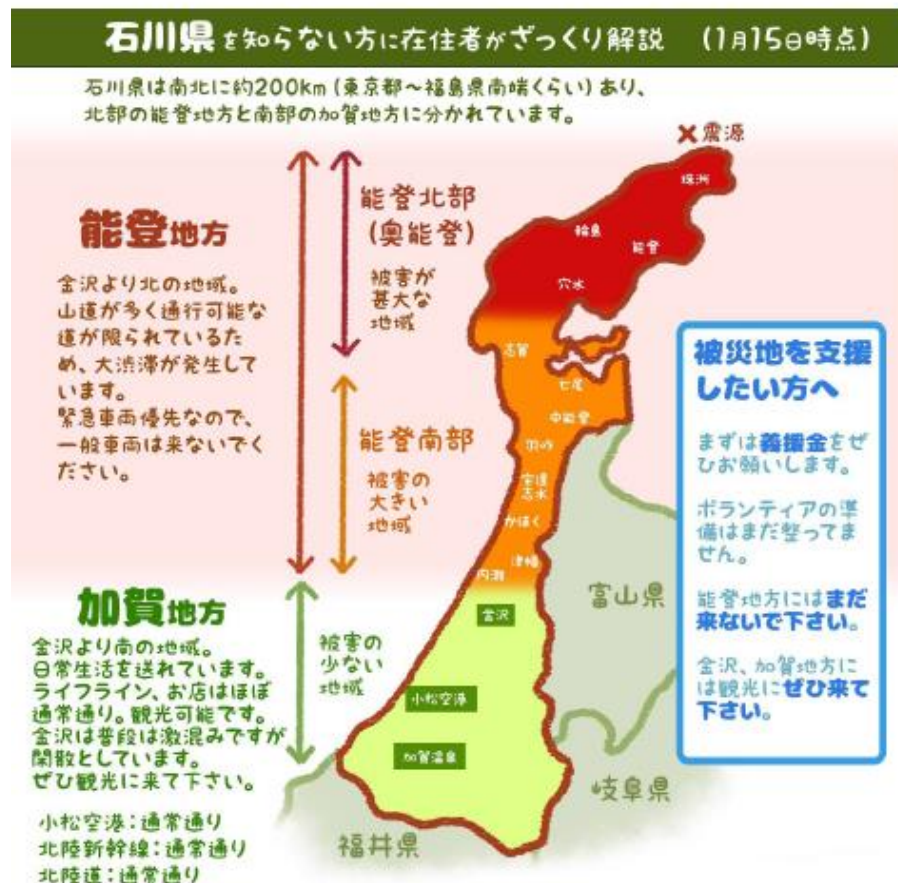
第1章

災害

令和6年1月1日16時10分ごろ 「令和6年能登半島地震」

- M7.6、最大震度7
- 全国より、被災地支援が行われた
- 愛知県隊が7次にわたって組織
（名古屋市は、そのうち2隊を担当）
- 映写スライド資料には、
東保健センター・野呂優樹先生の活動報告
を引用（印刷資料からは削除）

当時の状況（1/26～2/1支援班）



<https://twitter.com/natoriyuichiro/status/1747115565876195626/photo/1>



急性期医療機関

高齢者福祉施設

転院待ち

900人_(1/26) ⇒ 450人_(2/1)

ほぼ満床

災害医療コーディネーター
DMAT

金沢以南で 生じた課題

DMAT
東京都DHEAT

1.5次避難所

2次避難所

- ・ 一次的な避難所を想定していたが滞在が長期化, 要介護者増加
- ・ DMAT活動終了 (～2/10予定)

- ・ ホテル, 旅館が点在し, 管理困難
- ・ 自立して生活できない方が混在
- ・ 3,500人_(1/26) ⇒ 5,000人_(2/1)

DMAT
群馬県DHEAT
医師会

市町
保健所

問題点のひとつ

⑥1.5次避難所の視察, 課題と提案

ISC : いしかわ総合スポーツセンター



サンテン : 産業展示館2号館



1次避難所：最初に開設される避難所

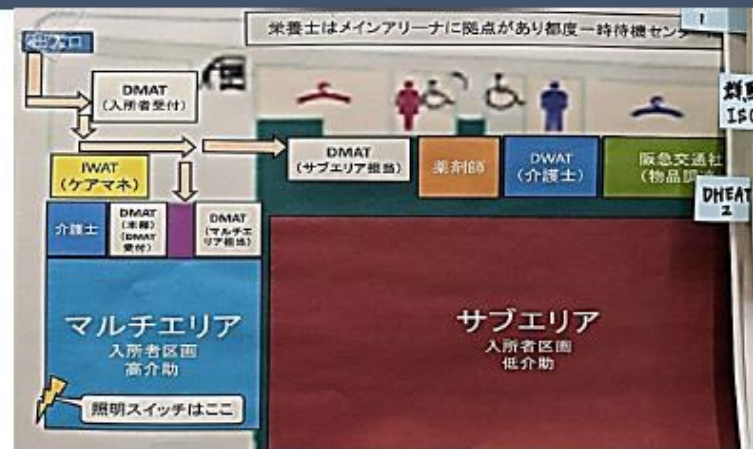
1.5次避難所：被災地外の一時的な避難施設

2次避難所：県内外のホテル・旅館 ※県内は金沢市以南
(生活困難者…ex. 高齢者・障がい者、乳児、その援助者・保護者)

* 東保健センター所長 野呂優樹先生作成資料

いしかわ総合スポーツアリーナのゾーニング

避難者のADLで分類した3つの滞在スペース @ ISC



ISCのエリア区分	通称	ADLでエリアを分類	最大収容人数	実状	医療	所管
メインアリーナ	メイン	自立して生活ができる	240名	避難者200名のうち 70名ほど介助が必要	医師会	県民文化スポーツ部 スポーツ振興課
サブアリーナ	サブ	マルチより介護度が低い	120名	69名	DMAT	健康福祉部 長寿社会課
マルチパーパスルーム	マルチ	介護度4～5	40名	23名	DMAT	健康福祉部 長寿社会課

メインとサブ・マルチ間で医療担当や所管課が異なり、管理が一元化できない

25

避難者の要介護度でゾーニングしたが・・・

* 東保健センター所長 野呂優樹先生作成資料

問題点のひとつ

サブエリア（マルチエリアより介護度低い）



運動施設のため、手すりがない、トイレが遠い等、介護職の負担が大きい



問題点：フレイルの促進など

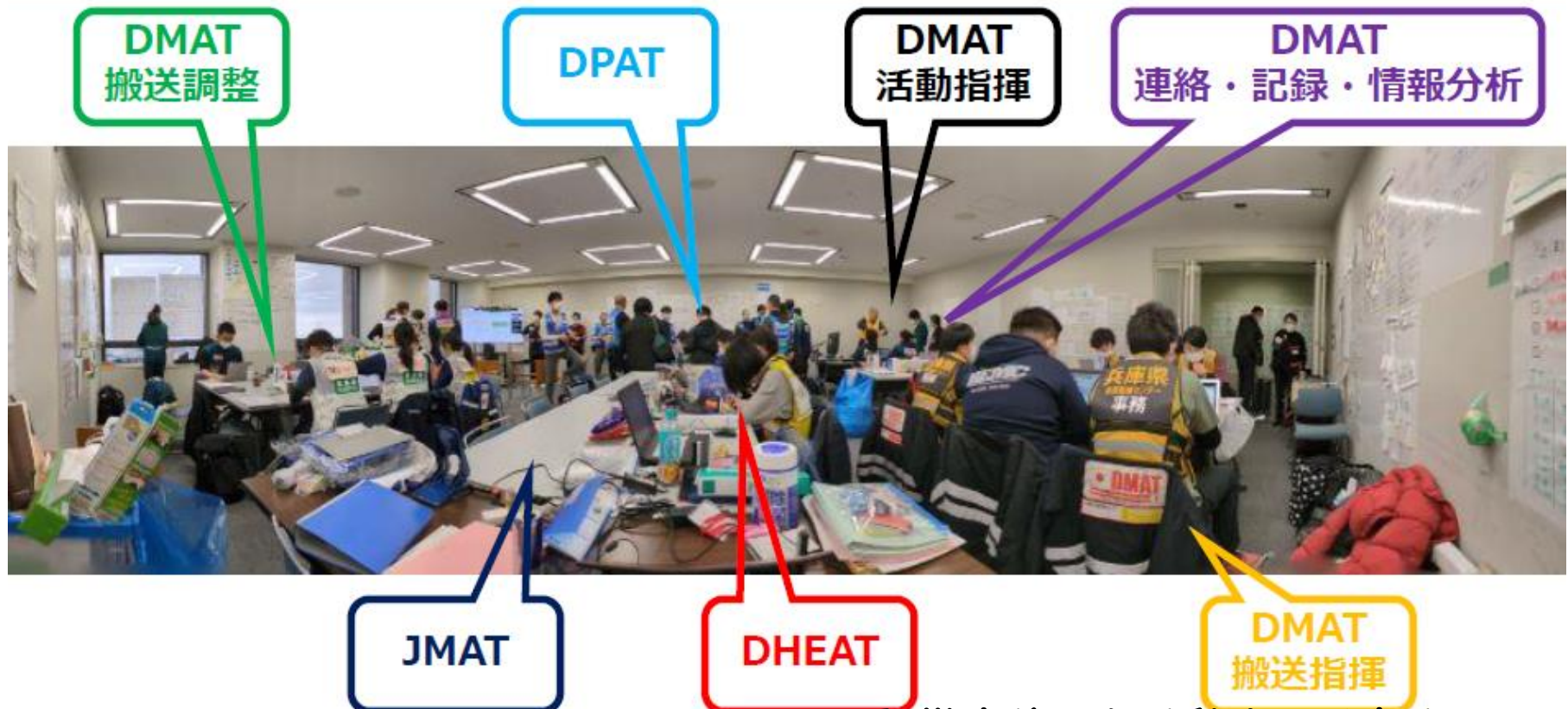
⑥1.5次避難所（いしかわ総合スポーツセンターと産業展示館）の視察、課題と提案

ISCの課題)

- ・避難生活の長期化が見込まれ、避難者の運動機能低下が懸念される
- ・運動施設のため、手すりがない、トイレが遠い等、介護職の負担が大きい
具体例：70人ほど入浴待機者がいるが、1人を入浴させるのに4人の職員が対応する必要があり、一日7人ほどしか入浴させれない
- ・新規、更新の介護申請が150件ほど滞っており、介護サービスが利用できない
- ・DMATやDHEATが介入していないメインの状況把握が十分できていない
- ・メインとサブ・マルチ間で医療担当や所管課が異なり、管理が一元化できない
- ・メインでも介護が必要な避難者が70名ほどおり、十分な対応ができていない
- ・清掃業務などを医療介護専門職が行っている実態があり、専門職の負荷を軽減するために、業務を整理し非専門職に業務を割り振る必要がある

指揮所の混雑

金沢以南を管轄する支援団体の詰所



Disaster Medical Assistance Team: 発災直後から活動する医療チーム

Japan Medical Association Team: 日常医療再生支援チーム (医師会)

Disaster Psychiatric Assistance Team: 災害派遣精神医療チーム

* 東保健センター所長 野呂優樹先生作成資料

会議！会議！会議！（8:30～21:40）

DHEAT第2班の活動記録（令和6年1月26日(金)～2月1日(木)）

	1月26日(金)	1月27日(土)	1月28日(日)	1月29日(月)	1月30日(火)	1月31日(水)	2月1日(木)
8:30		金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂、永田)	金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂、小嶋)	金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂)	金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂)	金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂)	金沢以南DMATの全体ミーティングに 参加(野呂)
8:45		全体DMAT会議(野呂)	全体DMAT会議(野呂)	全体DMAT会議(野呂)	全体DMAT会議(野呂)	全体DMAT会議(野呂)	全体DMAT会議(野呂)
9:00		3階 風戸の打ち合わせに出席(野呂、 永田、小嶋)	3階 風戸の打ち合わせに出席(永田)	3階 風戸の打ち合わせに出席(永田、 竹田、広田、小嶋)	3階 風戸の打ち合わせに出席(永田、 竹田、広田、小嶋)	3階 風戸の打ち合わせに出席(永田)	3階 風戸の打ち合わせに出席(永田)
9:15		調整本部、永田次長、北島連DHEAT 村松先生と打ち合わせ(野呂、永田)	金沢以南保健医療福祉調整本部会議に 内れた打ち合わせ(金沢)	野呂のいしかわ総合スポーツセンター と産業展示館2号館の訪問調整	石川中央保健福祉センターの調整 本部、東田次長と打ち合わせ	本部に野呂調整したスポーツセンター 本部に野呂調整したスポーツセンター	調整本部、東田次長と本部の金沢以南 保健医療福祉調整本部会議の資料調整 3階本部での資料調整(金沢)
9:30		追加質問のDMATからの情報提供の 状況確認(広田、竹田)			本部で金沢以南保健医療福祉調整本部 会議の資料確認		
9:45							
10:00		DPATから追加質問の調整者の状況 について確認調整	金沢以南保健医療福祉調整本部会議の 資料作成(小嶋)	石川中央保健福祉センター訪問(金沢)	金沢以南保健医療福祉調整本部会議 資料調整	金沢以南保健医療福祉調整本部会議 資料調整	金沢以南保健医療福祉調整本部会議 資料調整
10:15							
10:30							
10:45							
11:00							
11:15							
11:30							
11:45							
12:00							
12:15		DPATとの打ち合わせ(野呂、小嶋)	本部との金沢以南保健医療福祉調整本部 会議の資料調整(小嶋)				
12:30	石川中央保健福祉センター訪問(金沢)						
12:45							
13:00							
13:15	第2回 金沢以南調整本部会議の開催 (金沢)	第3回 金沢以南調整本部会議(金沢)	第3回 金沢以南調整本部会議(金沢)	第3回 金沢以南調整本部会議(金沢)	第4回 金沢以南調整本部会議(金沢)	第21回 金沢以南調整本部会議(金沢)	第3回 金沢以南調整本部会議(金沢)
13:30							
13:45							
14:00							
14:15							
14:30							
14:45							
15:00							
15:15							
15:30							
15:45							
16:00							
16:15							
16:30							
16:45							
17:00							
17:15	愛知県2班への引継ぎ(金沢)	金沢以南DMAT会議参加(野呂、永 田、小嶋)	金沢以南DMAT会議参加(野呂)	金沢以南DMAT会議参加(野呂)	金沢以南DMAT会議参加(野呂)	金沢以南DMAT会議参加(野呂)	金沢以南DMAT会議参加(野呂)
17:30							
17:45							
18:00							
18:15							
18:30							
18:45							
19:00							
19:15							
19:30							
19:45							
20:00							
20:15							
20:30							
20:45							
21:00							
21:15							
21:30							
21:45							
22:00							

金沢以南保健医療福祉調整

本部会議が、2日に1回の頻
度で開催

ここで話し合われたことが、
翌日の石川県保健医療福祉

調整本部会議で提示され、全
体で議論し方針が決定され

る
愛知県DHEATにとって、金

沢以南保健医療福祉調整本
部会議の対応が最重要業務

であった

会議準備に追われる日々で、
かなりハード

ルーチンの会議が多すぎ。8

* 東保健センター所長 野呂優樹先生作成資料

第1章まとめ

- 発災後は「とりあえず動く」ことから始まる
- 「とりあえず動いた」結果、色々な連携が後回しになる
- 連携するためには
「会議！ 会議！ 会議！」
 - ところで・・・
 - 会議資料や告知分を作るのに、
生成AIは有能



事件は会議室で起きている
んじゃない。現場で起きているんだ！
©踊る大捜査線The movie

第2章

保健所・保健センター

保健所・保健センター勤務の 公衆衛生医師の数

公衆衛生医師定員及び現員数調査(設置主体別)

設置主体	定員数						現員数					
	計	本庁	保健所	地方衛生 研究所	精神保健 福祉セン ター	その他	計	本庁	保健所	地方衛生 研究所	精神保健 福祉セン ター	その他
都道府県	746	132	424	28	48	28	659	141	401	20	58	39
指定都市	294	35	166	6	28	47	272	33	159	8	28	44
中核市	75	3	64	0	0	6	94	6	84	0	0	4
その他政令市	17	3	14	0	0	0	19	3	16	0	0	0
特別区	112	14	70	0	0	17	80	8	57	0	0	7
全国	1244	187	738	34	76	98	1124	191	717	28	86	94
* 定員数又は現員数の計のみに回答し、内訳毎の数値がない自治体があり、本庁～その他の合計と計が一致しないものがある。												
* 定員数なしの自治体もある。												

およそ1,200人（定員割れしている）

医師としてのレア度は

各学会認定専門医数

- 内科学会認定内科医 86,903名
- 外科専門医 24,259名
- 乳腺専門医 1,838名
- 放射線治療専門医 1,353名
- リハビリテーション科専門医 1,141名
- 小児外科専門医 695名
- 内分泌外科専門医 378名

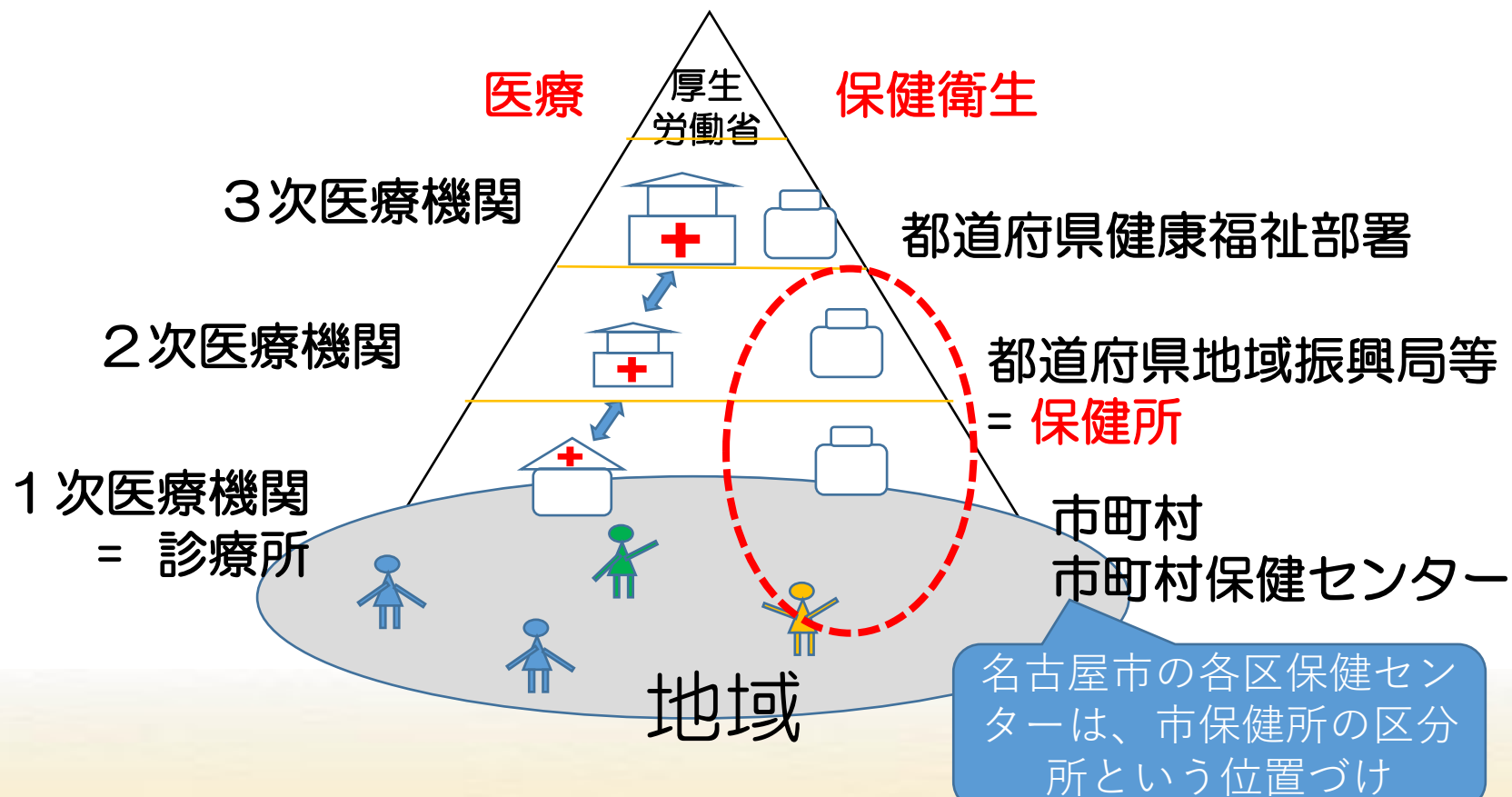
公衆衛生医師
1,124名

保健所・保健センターとは

医師国家試験 第114回 C問題 33問目
保健所の役割はどれか。3つ選べ。

- a. 3歳児健康診査
- b. 医療法に基づく立入検査
- c. 国勢調査の調査票の審査
- d. 地域における健康危機管理
- e. 人口動態統計の調査票の審査

日本の地域保健医療体系



from the document by IVC GMI

保健所の設置と我が国の公衆衛生の変遷 (保健所に係る主な法律や体制)

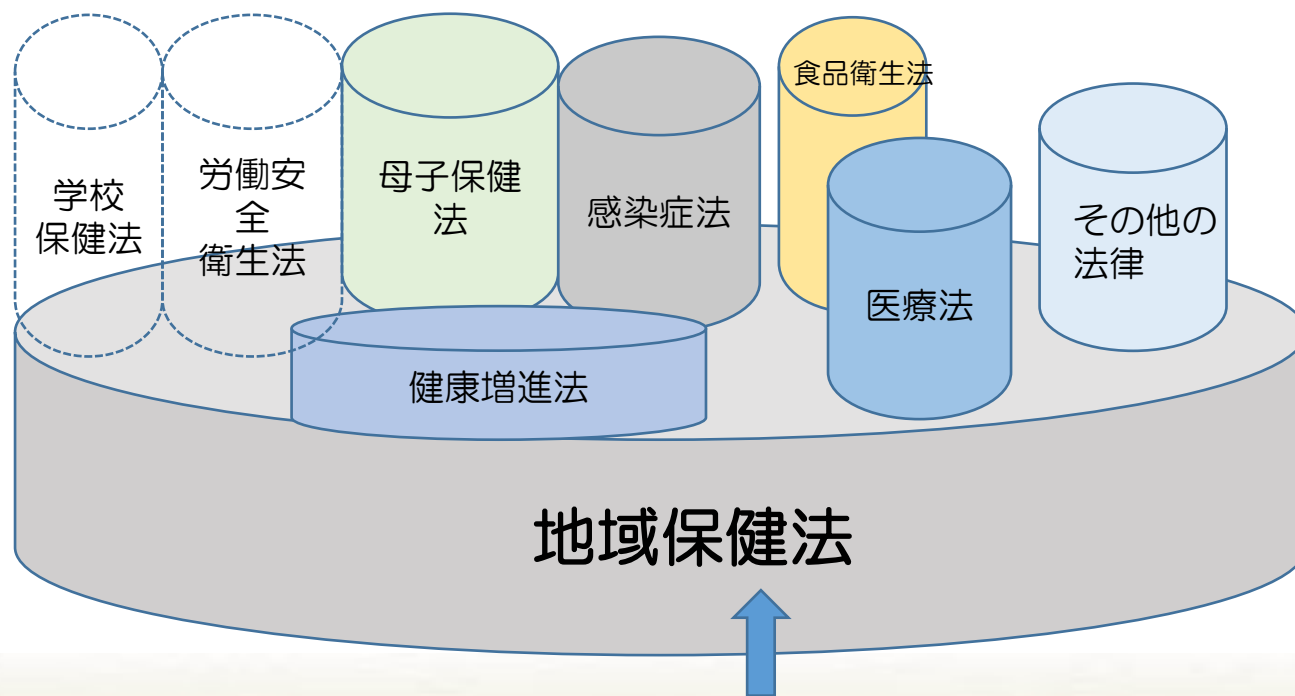
- 1945 **課題** **公衆衛生面（伝染病、栄養不良、不衛生な生活環境 等）**
- 1960' **医療面（医療の利用、貧困 等）**
対策 衛生行政の枠組み（厚生省、保健所設置）、UHC（国民皆保険）
 サーベイランスシステム（人口動態、伝染病患者の登録）
 対人保健、生活衛生改善（飲食品、廃棄物、水、大気、下水 等）
- **1947** **（新）保健所法**
- 1990' **課題** **高齢化、生活習慣病（脳卒中、心疾患、がん）、国際感染症、自殺、地方分権**
対策 地域保健体制の再編（保健所、市町村 保健センター）、介護保険
- **1994** **地域保健法（保健所法の改正）→**
• 2000- **保健所、市町村保健センター**
課題 **大規模災害の頻発、高齢化、人口減少**
対策 健康日本21（健康寿命の延伸）、地域包括ケアシステムの導入

公衆衛生医師の動く基準

× エビデンス

○ ルール

保健所の活動に関する法律



地域保健法には、基本的な考え方と目的、市町村の役割などが定められている

保健所は、主に“都道府県型”と“政令市型”がある

• 都道府県型

- 管内の市町村と協力して、関係機関と調整を行い、関係を構築して、食品衛生や感染症等の広域的業務、医事・薬事衛生や精神・難病対策等の専門的な業務を行う。また、大規模で広域的な感染症や食中毒の他、自然災害や原因不明の健康危機管理にとりくみ、地域全体の住民の健康のレベルアップを図っている。

細野注：「保健センター業務」

• 政令市型

- 都道府県型の保健所が行う専門的、広域的な業務に加え、市区町村の業務とされている乳幼児健診等の母子保健事業、特定健診・特定保健指導等の生活習慣病対策、更に、がん予防・検診など、市民に直接的な事業を行い、より地域に密着して、地域全体の健康づくりを推進します。

保健所と市町村保健センターの特徴

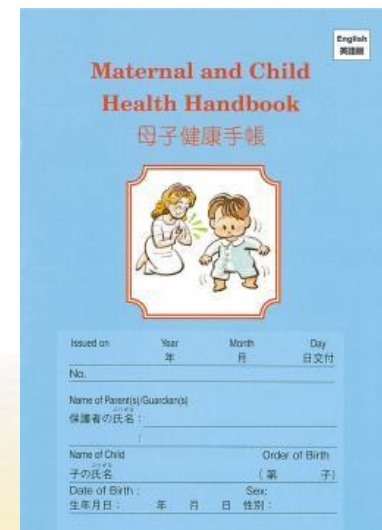
	保健所	市町村保健センター
設立	県 大都市（人口 ≥200,000）	市区町村
数	469	2456
主な 業務	• <u>専門的な個人サービス</u> (感染症, 難病 等) • 法律の執行 (医療機関, 食 品衛生 等)	• <u>住民の日常生活に深く関る個人 向けサービス</u> (母と子の健康、予防接種、障害 者、高齢者)
主な 職員	多くの公衆衛生専門職	保健師と栄養士

市区町村保健センターの業務

一般事務職員もしくは保健師によって運営されている
地域に根差したサービスを、住民に直接提供している（市町村）

1995年の地域保健法制定以降、以下のような業務が保健所から
市町村保健センターに移管された

- 小児の発達評価
- 母子手帳の発行
- 住民健診
- 保健指導
- 予防接種事業



地域保健法（保健所業務）

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

- 一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
- 二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
- 三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
- 四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- 五 医事及び薬事に関する事項
- 六 保健師に関する事項
- 七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
- 八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
- 九 歯科保健に関する事項
- 十 精神保健に関する事項
- 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
- 十二 感染症その他の疾病の予防に関する事項
- 十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
- 十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

保健所長

地域保健法施行令

第四条 保健所の所長は、**医師**であつて、次の各号のいずれかに該当する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。

- 一 **三年**以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
- 二 厚生労働省組織令（平成十二年政令第二百五十二号）第百三十五条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程（以下「養成訓練課程」という。）を経た者
- 三 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者

（第2項で、医師確保が著しく困難であるときは、医師でない者を所長にすることが可能、となっている）

保健センターについて

地域保健法第十八条

市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

- ② 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

* 所長の資格・免許の記載（制限）はない

保健所・保健センターまとめ

保健所

- 都道府県が設置
- 所長は医師
- 広域的・専門的・技術的推進のための拠点

保健センター

- 市町村が設置
- 所長の規定なし
- 住民サービス拠点

第3章 感染症

昔の感染症対策

明治35年（1902年）9月29日、横浜市海岸通のペスト患者初発に当り、患家に保菌ネズミも確認されたので、県および市当局は早期に局所での根絶を目指して、196戸1,256名居住に地域を10月30日から11日間

かけて**焼却**した。

強制ではなく、交渉の結果、当局が住宅を買収（1戸あたり168円）するという補償を行っている。

感染症の対応？

Q：保健所の人はこちらを着るの？

A:着ます

2009年も着ました

その時は初夏

コロナ期は一年中、着てました



感染症患者と人権 ～感染症対応の前に～

- 人権のある患者
 - どこで誰と会ってもいいでしょう？
 - 病院キライだから入院とかしたくない！
いいでしょう？
- 患者周囲の、人権のある人間
 - 感染源が隣にいるかもしれないなんて
怖い生活したくないです！
- どちらの意見が大事なの？

感染症にかからない権利は？

昭和二七年六月六日

最高裁判所第二小法廷判決（抜粋）

しかし、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずにウイルスを他人に感染させる場合にも成立するのである。

性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人にウイルスを感染させた以上、当然傷害罪は成立するのであるから論旨は理由なき見解というべく、憲法違反の問題も成立する余地がない。

感染症患者をめぐる法律①

- 「感染症法」に基づいて対処される。
- （1類・2類・3類・4類・一部の5類）感染症患者を診断した医師・獣医師は、ただちに最寄りの保健所を通じて都道府県知事にこれを届け出なくてはならない。
（怠ると50万円以下の罰金）

正式名称：
感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律

感染症患者をめぐる法律②

• 感染症患者診断時の届出（1～4類・一部の5類）

直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届出

都道府県（知事）に・・・保健所（長）を通じて

• 厚生労働省令で定める事項

- | | |
|------------------|-----------------|
| 一 当該者の職業及び住所 | 七 感染推定年月日・発病年月日 |
| 二 （保護者の氏名及び住所） | 八 病原体に感染した原因、 |
| 三 感染症の名称及び当該者の症状 | 感染経路、病原体に感染した |
| 四 診断方法 | 地域 |
| 五 当該者の所在地 | 九 診断した医師の住所 |
| 六 初診年月日及び診断年月日 | 十 その他必要事項 |

個人情報保護に関する法律

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

- 一 法令に基づく場合

よって「第三者である知事へ情報を届出るのは個人情報保護法違反！」・・・ではない

感染症患者をめぐる法律③ー 1

類型	解説	対応
1類	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症	入院＊
2類	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症	入院
3類	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症	就業制限
4類	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症	獣医師の届出 動物輸入規制 消毒、駆除、 廃棄
5類	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、発生・まん延を防止すべき感染症	感染症発生動 向調査情報公 開

＊有症状の患者、無症状病原体保有者、疑似症患者

感染症患者をめぐる法律③ー 2

類型	解説	対応
新型インフルエンザ等感染症	一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、全国的大流行により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの	例： COVID19… 2類同等時代
指定感染症	既に知られている感染性の疾病で、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの	例： COVID19… 2類同等時代
新感染症	人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病と明らかに異なるもので、かかった場合の病状の程度が重篤であり、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの	

第114回看護師国家試験

午前88問

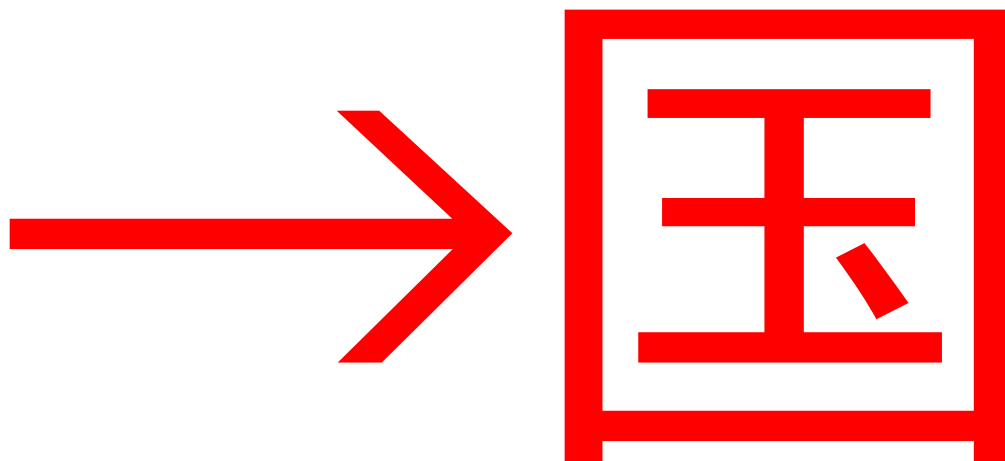
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で、2類感染症に分類されるのはどれか。2つ選べ。

- | | |
|----------------|---|
| 1. ポリオ〈急性灰白髄炎〉 | ○ |
| 2. 細菌性赤痢 | × |
| 3. 狂犬病 | × |
| 4. 百日咳 | × |
| 5. 結核 | ○ |

2と3が違うことだけ、今日は覚えて帰りましょう

感染症患者をめぐる法律③ー 3

誰が感染症対策をす
るのか



感染4症患者をめぐる法律③ー4

医師（3年後の君たち）の役割

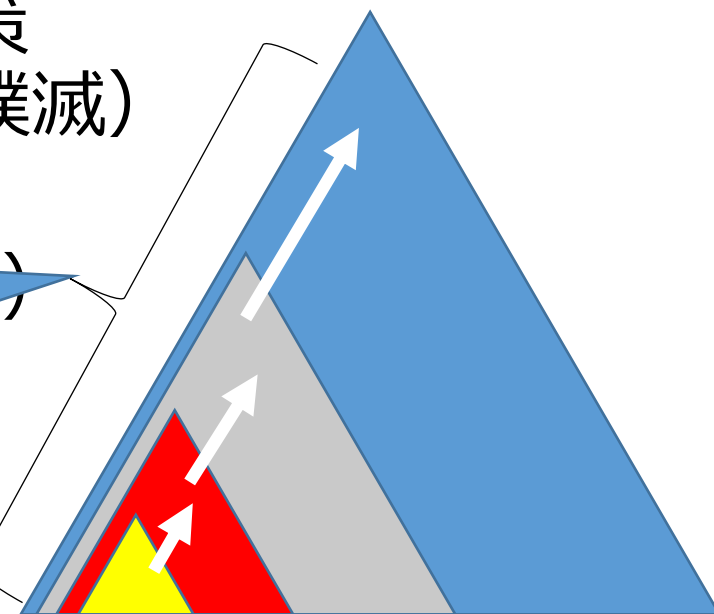
1. 国連：地球規模の感染症対策
(ex: 天然痘、ポリオ、麻しん撲滅)

2. 国：国
(ex: 感染症発生動向調査報告書(感染症発生状況)の作成)

3. 都道府県：県単位の対策
(ex: 感染症病床数の決定)

4. 病院：症例単位の対策←！！！！

情報をひとつずつ順番に
上げて行って集積して、
広域レベルの対策に
つなげていく



感染4症患者をめぐる法律③ー5

感染症患者の届出

- 一類感染症

感染力及び罹患した場合の重篤性等から総合的な観点から極めて危険な感染症

全数届出

- 二類感染症

感染力及び罹患した場合の重篤性等から総合的な観点から危険な感染症

全数届出

- 三類感染症

感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づいて総合的な観点からみた危険な感染症
業への就業によって感染を拡大するおそれがある感染症

全数届出

- 四類感染症

人から人への感染はほとんどないが、感染する可能性があり、感染症

全数届出

- 五類感染症

国民の健康に影響を与えない軽微な感染症

全数届出

サンプル届出

レジメ別紙

「感染症法における感染症の分類」

感染症情報公開（名古屋市公式ウェブサイト）



名古屋市

City of Nagoya

緊急情報なし

防災ポータル

質問する

あ ふりがな

読み上げ

文字サイズ・配色

Language

情報さがす

防災・安心安全

くらし・手続き

子ども・子育て・教育

健康・医療・福祉

観光・文化・スポーツ

市政情報

事業者向け

現在の位置：[トップページ](#) > [健康・医療・福祉](#) > [衛生](#) > [名古屋市衛生研究所](#) > 名古屋市感染症情報センター

名古屋市感染症情報センター



ページID1015388

印刷

大きな文字で印刷

名古屋市感染症情報センターのトピックス

インフルエンザ

感染症の動向調査・発生状況

名古屋市感染症発生動向調査情報(週報・月報)

毎週の感染症発生状況をPDFファイルで掲載しています。

1類から5類感染症(全数把握)の発生状況

名古屋市の感染症発生動向調査結果(1類から5類まで)について、最新の週単位の情報を掲載しています。期限を切って情報を収集しているため、後に記載内容が変更される場合があります。

健康・医療・福祉

衛生

名古屋市衛生研究所

衛生研究所のご案内

衛生研究所のトピックス

名古屋市感染症情報センター

衛生研究所 事業概要

放射性物質の検査

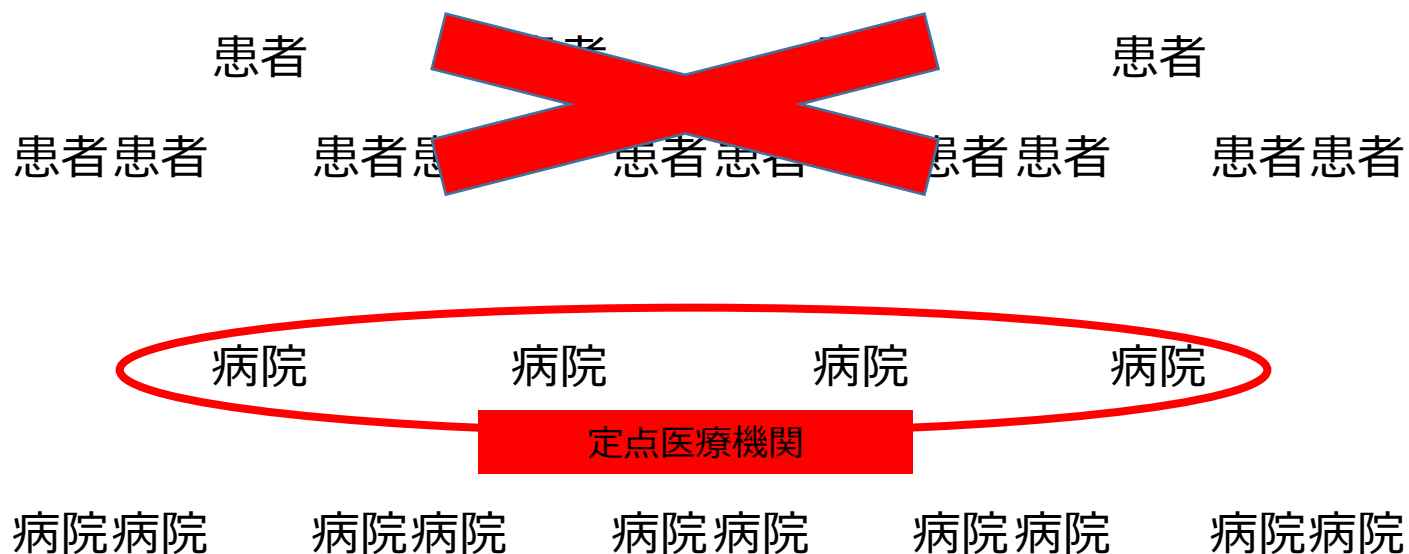
重要なお知らせ

Jアラート全国一斉情報伝達試験(第1回)のお知らせ

市指定ごみ袋に関する市民の皆

感染症患者をめぐる法律③ー 4

サンプリングの方法



感染 4 症患者をめぐる法律③ー 5 サンプル届出の感染症（五類の一部）

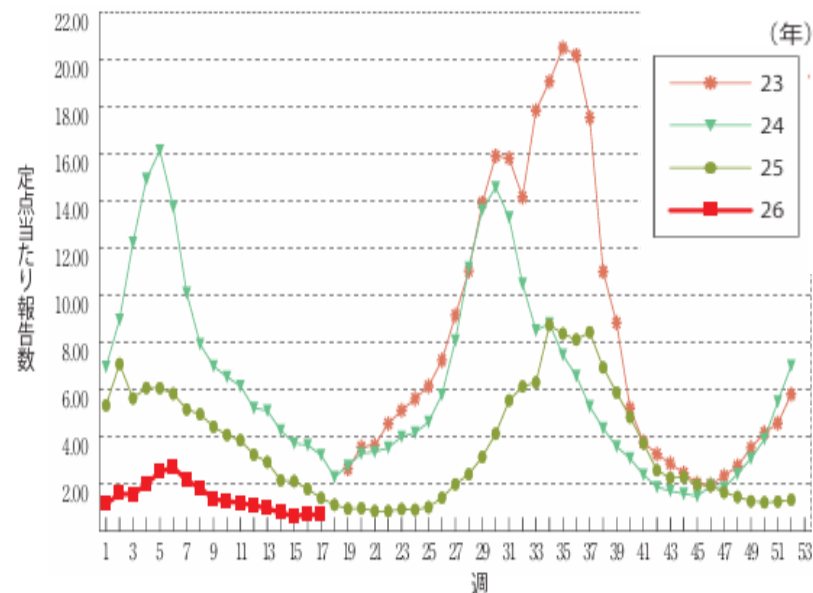
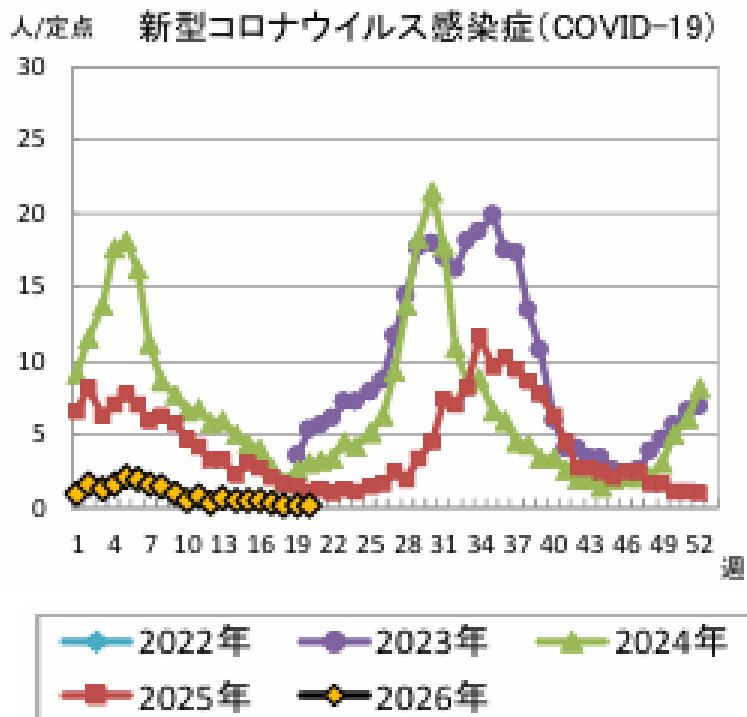
- 定点医療機関（全医療機関ではない）が患者数を保健所を通じて都道府県（知事）に報告する
- 週 1 回の報告
（インフルエンザ定点：全国約5,000か所）
（性感染症は月 1 回・全国約1,000か所）
- 都道府県（知事）はこれを集計して感染症流行状況を把握する
- 都道府県（知事）は厚生労働大臣に集計結果を報告して、厚生労働大臣は全国集計を作成する

感染症患者をめぐる法律③ー 6

集計の結果（名古屋市・2026年第20週、 全国：2026年 第17週）

感染性胃腸炎（名古屋）

感染性胃腸炎（全国）



感染症患者をめぐる法律④

- 感染症罹患が疑われる患者の診察
（医者にかかりたくない！対応）
 - 都道府県知事は健康診断を勧告する
 - 勧告を断った者には健康診断措置をとることがある
- つまり断っても罰則はない

感染症患者をめぐる法律⑤

- 感染症患者の入院

(入院したくない！ 対応)

- **都道府県知事**は入院を勧告する
- 勧告を断った者には入院措置をとることがある

- つまり断っても罰則はない

.....だったが令和3年から
過料50万円以下

(コロナ期に病院から脱走する患者が多発した)

感染症患者をめぐる法律⑥

- 感染症患者の就労

(こっそり働いてやる！対応)

- 知事は就労制限を通知する

- 就労制限業務の種類は3つ

1. 他者の身体に直接接触する業務

2. 接客業その他の多数の者に接触する業務

3. 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

(罹患した感染症によって制限業務が異なる)

- 通知を無視する者には刑罰が課せられることがある
(30万円以下の罰金)

感染症患者をめぐる法律⑦ー 1

- 感染症患者の治療費

- 入院勧告・入院措置中の医療費は原則公費負担の対象（無料）である
- 結核患者に関しては、退院後の通院治療も公費負担の対象（95%引き）である
- ただし両方とも、保健所長を通じて都道府県知事に申請しないと公費負担は受けられない

感染症患者をめぐる法律⑦ー 2

結核の標準治療法

抗結核薬のうち最強のものを4種類併用

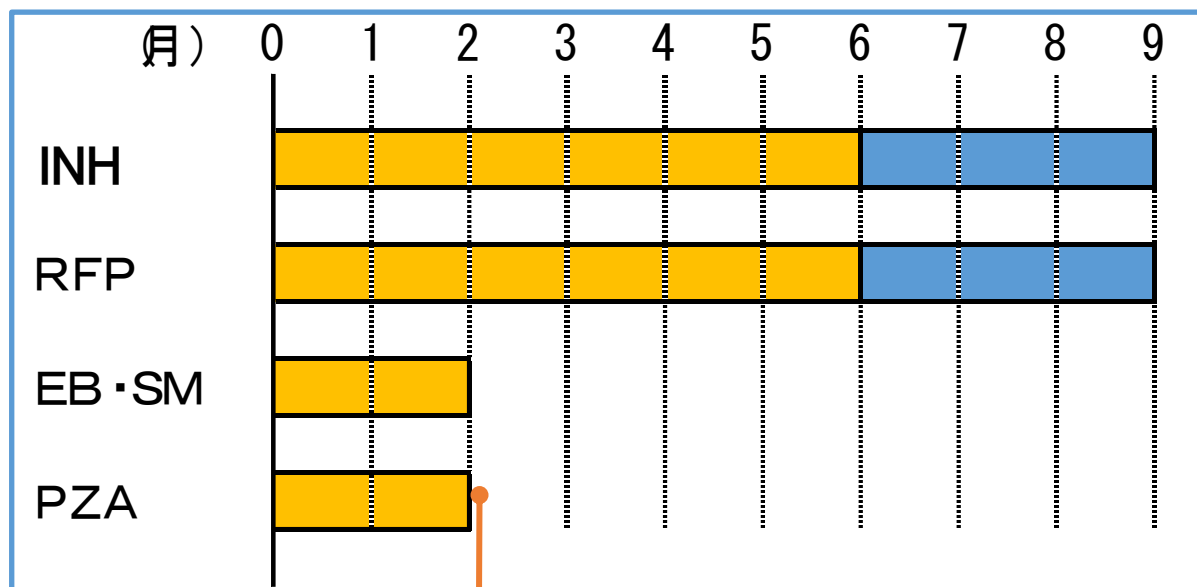
2か月、

その後2種類

最低4か月継続

計6か月

(3月延長可)



たいてい、このへんで退院 (感染性消失)

感染症患者をめぐる法律⑦ー 3

結核菌の再増加に関する問題

各薬剤耐性菌の割合（初回治療）（同・再治療）

INH	4.4%	33.0%
RFP	1.4%	21.6%
SM	7.5%	24.2%
EB	<1%	15.2%
全複数耐性	20.7%	64.3%
INH/RFP	0.80%	19.7%

外来治療費公費負担制度の目的:

症状が消失しても、耐性菌発生防止のため、体内結核菌の全滅まで
外来治療を継続する必要がある

感染症患者をめぐる法律⑧

• 感染症診査に関する協議会

- 入院の是非、
- 結核公費負担の要否

について、検査結果をもとに（PCR結果とか）
患者の感染性/入院の妥当性を診査（審査）する



* ただし結核は入院延長勧告・入院延長通知は30日以内

感染症患者をめぐる法律⑨

権利の背反と折り合いをつける

- 患者のプライバシー権 保護
- 移動の自由 制限
- 就労の自由 制限
- 診察を受けない権利 制限

第4章

精神保健

看護師国家試験第105回

- 精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。

1. 私宅監置の廃止
2. 任意入院の新設
3. 通院医療公費負担の導入
4. 精神障害者保健福祉手帳制度の創設

精神保健の歴史

いつ	制度	内容
1900	精神病患者監護法	私宅監置
1950	精神衛生法	公的精神病院の設置等
1965	精神衛生法改正	保健所の精神保健対応 通院公費負担制度
1987	精神保健法	精神医療審査会 任意入院制度創設
1993	(障害者基本法)	
1995	精神保健福祉法	社会参加の促進 精神障害者保健福祉手帳

ライシャワー

厚生労働省「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」

<https://www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/law.html>

ライシャワー事件

1964年（昭和39年）3月にアメリカ大使館門前で当時19歳の統合失調症患者にナイフで大腿を刺され重傷を負った。

（Wikipedia「エドウィン・O・ライシャワー」

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%B0%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%83%BC>）

事件後、**精神障害者の入院を強制するか否か、世論が沸騰**したが、終着点は「精神保健の第一線を**保健所**とする」ことで精神障害者の医療福祉を絶やさないことを法律（精神衛生法昭和40年改正）

精神障害者の人権①

(困ったこと)

- となりの人が、朝から「電波を飛ばすな！」と自宅に向かって叫んでいる。出勤しようとする
と恐ろしい目つきで睨んできて、生命の危険を
正直感じる

(どうするか?)

- ① 逮捕してもらう
- ② 医療機関の受診（入院）をしてもらう
- ③ そのまんま放置

精神障害者の人権②

- 周囲の人の人権を考えれば、精神障害者を取り押さえることが必要・・・なのか？
- むやみやたらに「精神疾患があるから」と入院隔離することはしない。
- 昔は違った
 - 東京番人規則二九条
路上狂癲人アレバ、之を取押へ警部ノ指揮ヲ受クベシ

精神障害者の人権③

刑法第三十九条

心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

- 人権のある患者
 - どこで誰と会ってもいいでしょう？
 - 病院キライだから入院とかしたくない！いいでしょう？
- 患者周囲の、人権のある人間
 - 無敵の人が隣にいるかもしれないなんて怖い生活したくないです！
- どちらの意見が大事なの？

精神障害者の人権④

精神障害者vs. 一般人

精神障害者

「プライバシーとか移動の自由とかあるだろがオラ！」

一般人

「ヤバイ！晒せ！閉じ込めろ！」

犯罪加害者vs. 一般人

犯罪加害者

「プライバシーとか移動の自由とかあるだろがオラ！」

一般人

「ヤバイ！晒せ！閉じ込めろ！」

精神科対策のために、患者を拘束(入院)
させるのは許されるのか？

入院すべきか？

- **精神保健指定医**が診察し、患者に自傷他害のおそれがあると診断されたら、都道府県知事は（緊急）措置入院させることができる

1名

2名

緊急措置
72時間以内

措置入院

入院のスタイル4つ

- 措置入院/緊急措置入院
 - 自傷他害のおそれ
- 医療保護入院
 - 本人の同意がとれない
- 応急入院
 - 措置するほど症状は激しくないが本人の同意が取れず、緊急に入院する必要がある
- 任意入院
 - 本人が望んで入院

措置入院のシステム

- 都道府県知事
 - 感染症患者の入院勧告/措置と同じ
- 精神医療審査会で適切な入院か審査をうける
 - 感染症法での感染症診査会と同じ
 - ただし根拠は感染症と違って
- 入院費用
 - 措置入院の場合は公費（税金）
 - それ以外は患者負担
 - ただし医療費減免制度（自立支援医療）は別にあるので、かなり安くなることが多い

感染症/精神入院の人権制限はなぜ、知事がするのか

保健に関連する勧告、措置、命令等々を出しそうな方々

- 天皇
- 内閣総理大臣
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 病院長

・・・の中で、なぜ都道府県知事が行うのか？

(考え方の例)

直接選挙で民意の反映を受けるから

第5章

感染症危機管理の実際

ちょっと結核の話

- 日本における新規患者数は、**11,519**人
(11.5人/10万人)
- うち、名古屋市は**336**人
(18.1人/10万人・政令指定都市中第3位)
保健所で扱う**最大の感染症**

* データはいずれも2021年

結核にかかった方々



明人
(上皇)
1933 - 現在



JOY
(モデル)
1985 - 現在



箕輪はるか
(漫才師)
1980 - 現在



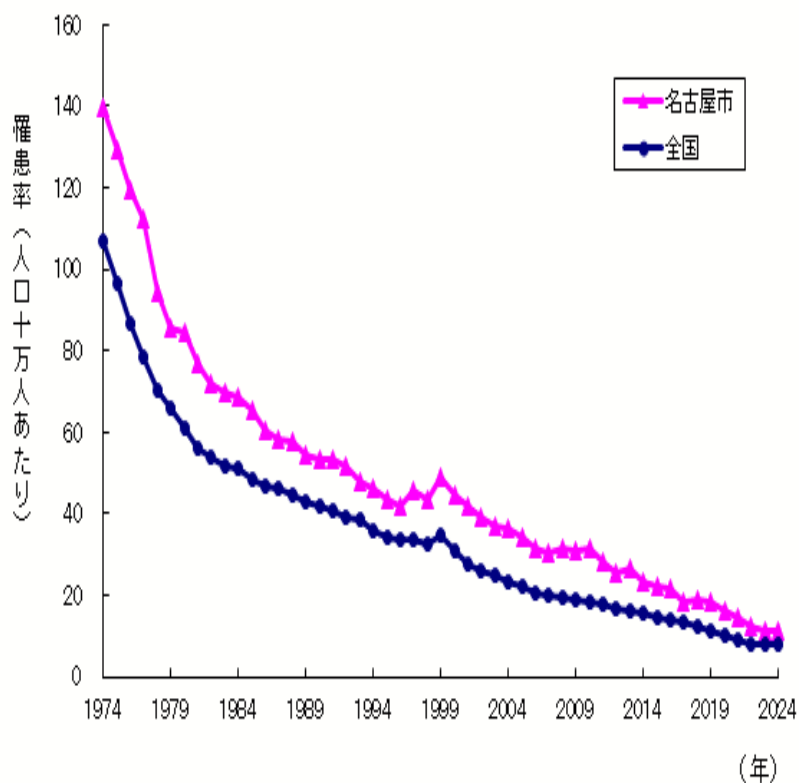
樋口一葉
(作家)
1872 - 1896



武田信玄
(戦国武将)
1521 - 1573

結核罹患率・死亡順位の推移

名古屋市罹患率（10万対）



死亡順位・死亡率（10万対）

	全結核		悪性新生物	
	順位	死亡率	順位	死亡率
昭和25年	1位	146.4	5位	77.4
26	2位	110.3	4位	78.5
30	5位	52.3	2位	87.1
35	7位	34.2	2位	100.4
45	8位	15.4	2位	116.3
60	16位	3.9	*1位	156.1
平成元年	18位	2.9	*1位	173.6
10	22位	2.2	*1位	226.7
28	28位	1.5	*1位	290.3
29	30位	1.8	*1位	299.4
令和6年	-	1.2	*1位	319.3

*悪性新生物は昭和56年から1位
#令和6年の結核死亡の順位は非公表

保健所では現役の「結核」

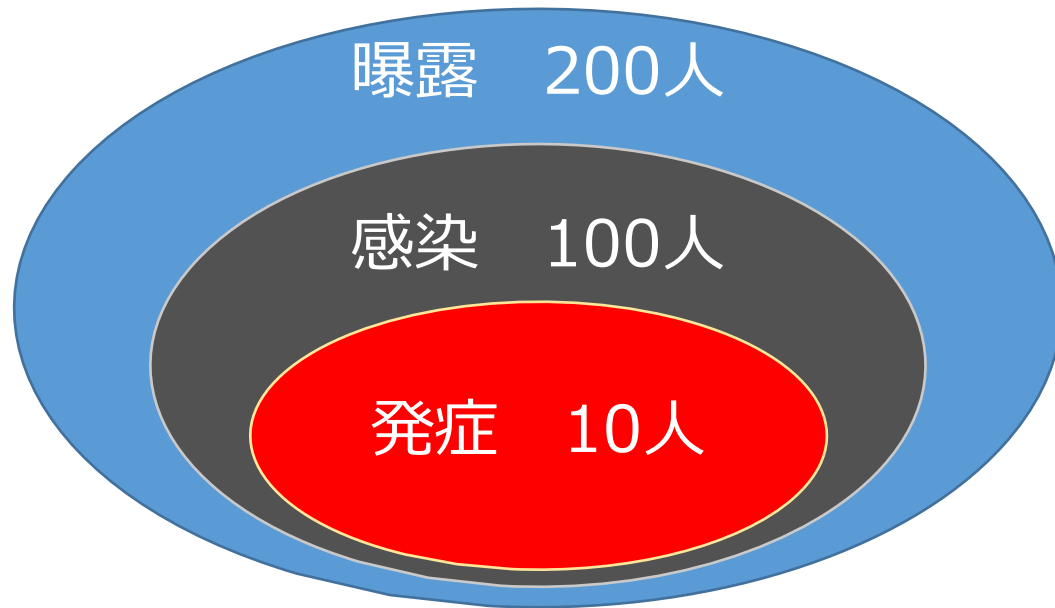
- 65歳女性同僚が肺結核になった！



**うつる！
うつされた！
うつしてしまう！
どうしよう！
(パニック)**

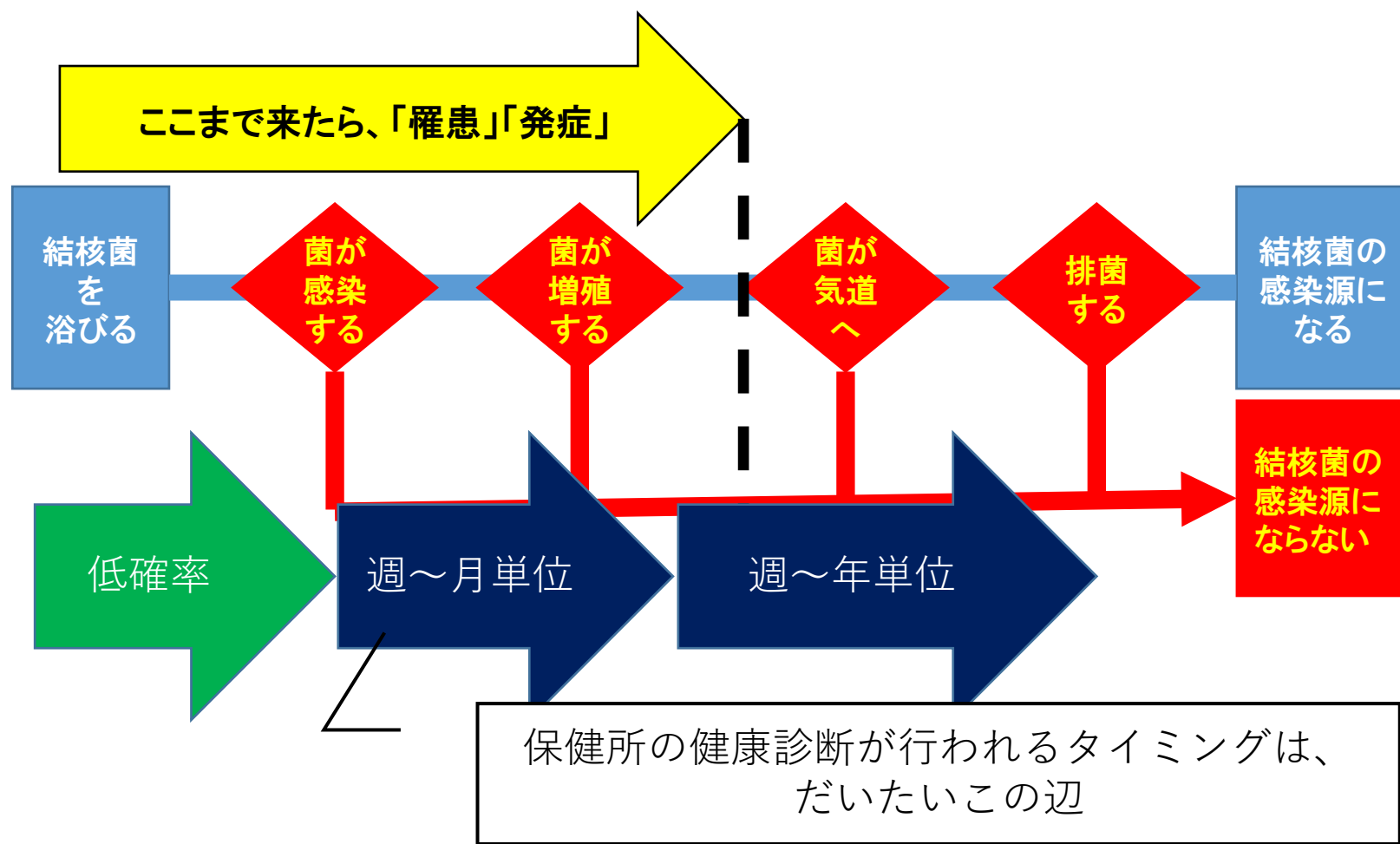
↑よくあるコレ
やめてください

「曝露」「感染」「発症」のイメージ



***結核菌の有意な「曝露」は、同一空間内8時間以上の接触**

「曝露」「感染」「発症」のタイムラグ④



新型コロナウイルス感染症

名古屋の日本男性、感染 60代、ハワイ旅行後に入院

2020年2月15日 01時00分 (5月27日 04時34分更新)

新型コロナウイルス
職の日本人男性の感
いているという。

市によると、男性
で上昇したため、市

九日は自宅静養し
が十三日に症状が悪
性を確認した。

男性は発症前の二
した以外には外出し

市保健センターの
着用していなかった

市は十四日夜に軒
かにしなかったが、

名古屋の感染、妻も確認 名鉄や中部空港を利用

2020年2月16日 02時00分 (5月27日 04時33分更新)

新型コロナウイルスによる肺炎（COVID（コビッド）19）を巡る問題で、名古屋市は十五日夜、市内在住の六十代無職の日本人女性の感染を確認したと発表した。女性は十四日に感染が確認された六十代男性の妻で、夫から感染した可能性が高いとみられる。医療機関に入院中だが症状は軽いという。

市によると、女性は先月二十八日から夫と米国ハワイ州へ渡航。滞在中や帰国後は症状がなかったが、十三日に市内の医療機関に入院した夫に付き添って救急車に同乗し、帰宅した夜に微熱と頭痛を発症した。

翌十四日に三七・六度の発熱があり、夫の入院先の医療機関を受診。いったん帰宅したが、市衛生研究所の遺伝子検査でウイルスの陽性反応が出た十五日に、別の医療機関に入院した。

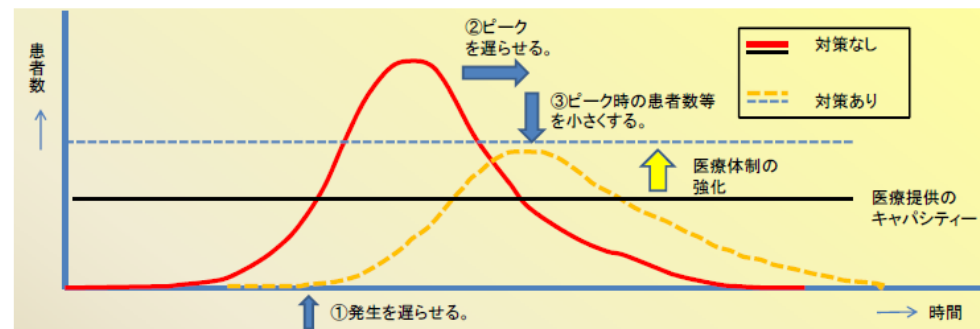
女性は夫と子ども一人との三人暮らし。市は遺伝子検査で子どものウイルス陰性を確認し、夫妻を診察した医師や夫を搬送した救急隊員ら濃厚接触者の健康確認を続けている。

市はまた、前日開いた緊急会議や十五日の日中に市民の相談を受け付けた窓口では明かしていなかった行動経路を詳細に

都道府県 新型コロナウイルス 感染者が確認された ※15日午後	北海道	2人	京都府	2
	千葉県	4	大阪府	1
	東京都	14	奈良県	1
	神奈川県	4	和歌山県	5
	愛知県	5	沖縄県	1
	三重県	1		
	(チャーター機帰国者、クルーズ船の乗船者を除く)			

新型インフルエンザの時の 対策目標を思い出す

- 流行の開始とピークを遅らせること
(不顕性感染が相当割合あるため、いくら島国でも、
感染者完全シャットアウトは不可能)
- ピークを遅らせ
- ピークを減少させ
- 発生を遅らせる



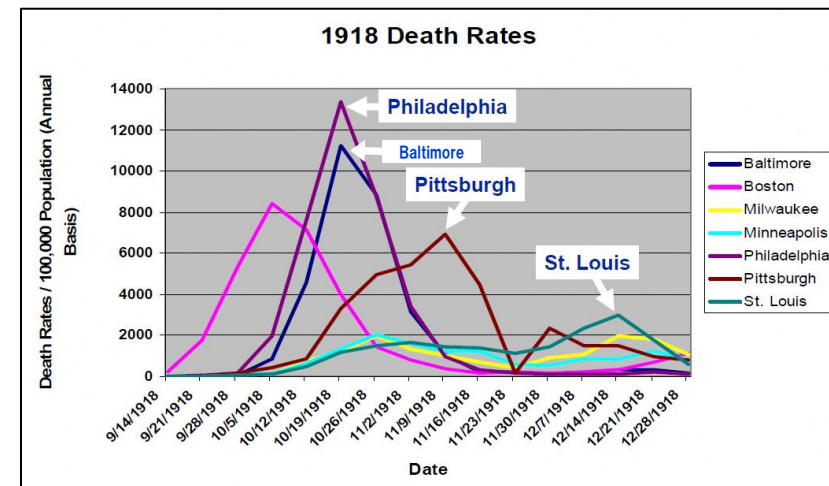
過去の新型インフルエンザ流行時の対策を踏襲する

- スペインかぜ（1918～19）は、インフルエンザパンデミックであり
全世界で6億人が感染、4～5,000万人が死亡した
- PhiladelphiaやBaltimoreと比べ、PittsburghやSt. Louisは低死亡率
 - 劇場・サロン閉鎖
 - 教会閉鎖
 - 学校閉鎖
 - スポーツ大会延期



実はこの手の対策は

「新型インフルエンザ特措法」による

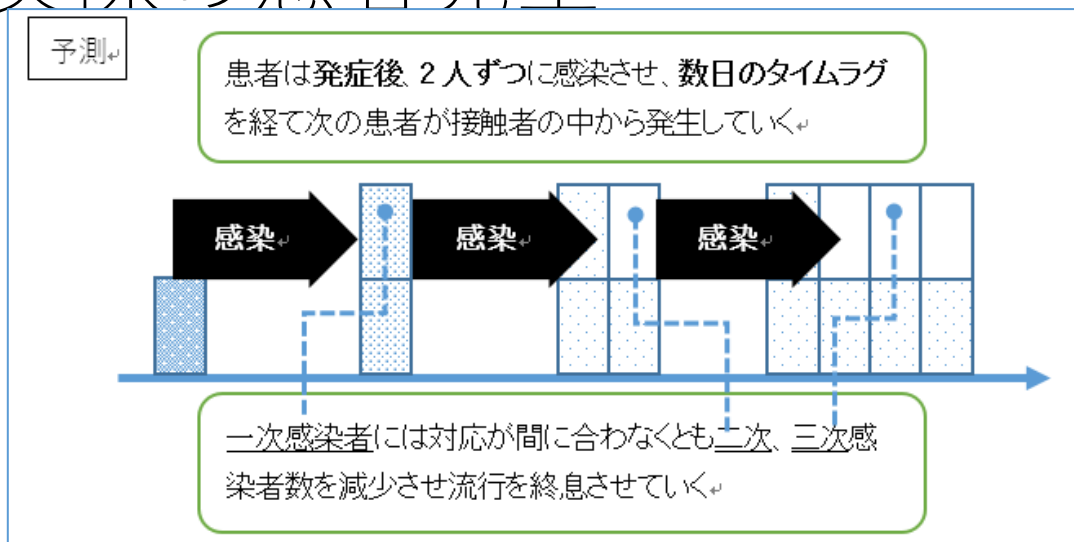


2020年2月14日

- 名古屋市最初の新型コロナウイルス感染症患者が発生した
- 最初の患者は
 - 帰国後、乗っていた電車、帰宅までの道程を記者発表
 - 立ち寄ったところに保健所・保健センターが「こういうところをこう消毒したほうがいいですよ」とアドバイス
 - 立ち寄り施設ウェブサイトの微妙な表現
 - 「保健センターの指示を受け、消毒をしました」
 - **「ここも消毒しろ! (# 皿)」**と朝から晩まで電話
- マスクのない時代でした...
- 接触者の健康診断結果は全員陽性
 - PCR検査は午後開始、結果判明は夜
 - 朝から夕まで電話で罵倒され、夜は**死の宣告**「あなたは陽性です」
- 入院後は「別日検体連続2回分のPCR陰性」
 - 陰性→陽性→陰性…の患者がいつまでも退院できない

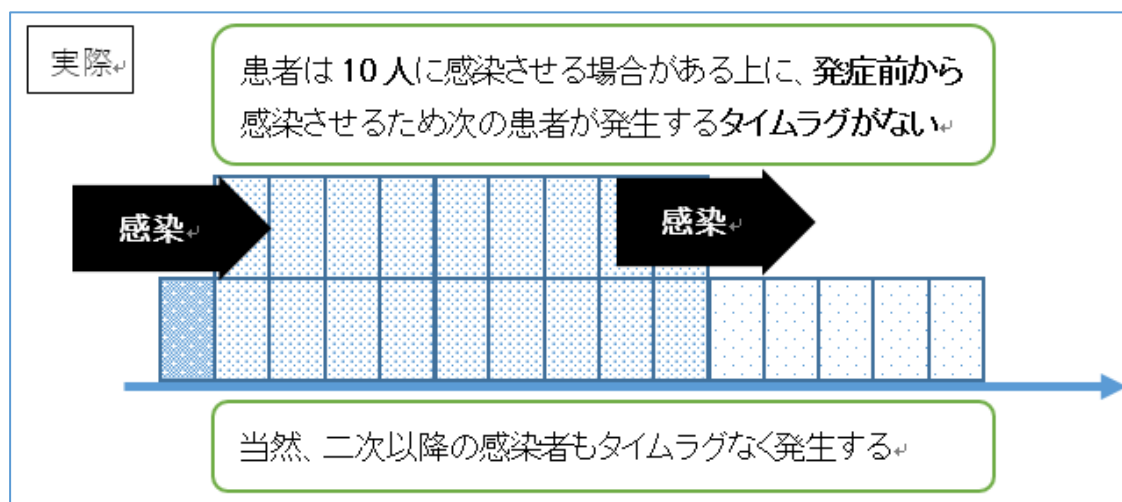
当初の予測と、実際の患者発生

- 潜伏期間は14日
- 基本再生産値は2~3
- 発症前感染はありうる
(予測) 2~3日経ったら
次の患者が2人程度出る



(結果)

- 発症前の感染性が一番強い
- 特定条件下（三密）では再生産数が10~20になる



名古屋市保健所長（前・市大理事長） 浅井清文の**英断**

- 厚労省見解「接触者は発症後から考える」
 - 浅井「発症2日前からの接触者を疑う！」
- 結果、名古屋市の判断が正しかった
 - 患者の調査で市外在住の接触者が判明した場合、
現地の保健所は接触者の対応をしない
 - これら接触者、保健所と、名古屋市の
保健所・保健センターとで喧嘩
 - でも、「名古屋市にとって接触者だけど、
名古屋市以外にとってはそうでない人」が
次々発症していく・・・

さらなる試練が

- 発熱患者「どこの病院にかかったら良い？」
- 保健センター「宣伝になるから、個別医療機関を案内できないの。近くにAクリニックがあるけど・・・」
- Aクリニック

「うちに発熱患者を紹介するんじゃないか！ (# °皿°)」

- 発熱患者「**お前に『行け』と言われたところが診てくれないじゃないか！ (# ˘皿˘)**」

感染症の調査

想像してほしい

「患者の、接触者はどういう人か？」

たいがい近い人間。友人、ママ友、恋人、学友、同僚・・・

- 患者「あのママ友に、死病をうつしちゃったの？（絶望）」
- 治癒後の社会生活は、どうなるのだろうか・・・
- 当時本当に「晒せ！」世論が沸騰していた。
 - 病院に患者が立ち寄った→保健所「同一時間帯にあなたがいました。」
 - SNSで拡散「ここに患者がいたらしいぞ！保健所が電話をかけてきた！」
 - SNS「何？！？じゃあ、ウチの近くか！どこだ晒せ！コロナは家族ともども晒せ！名乗り出ろ！吊るせ！」

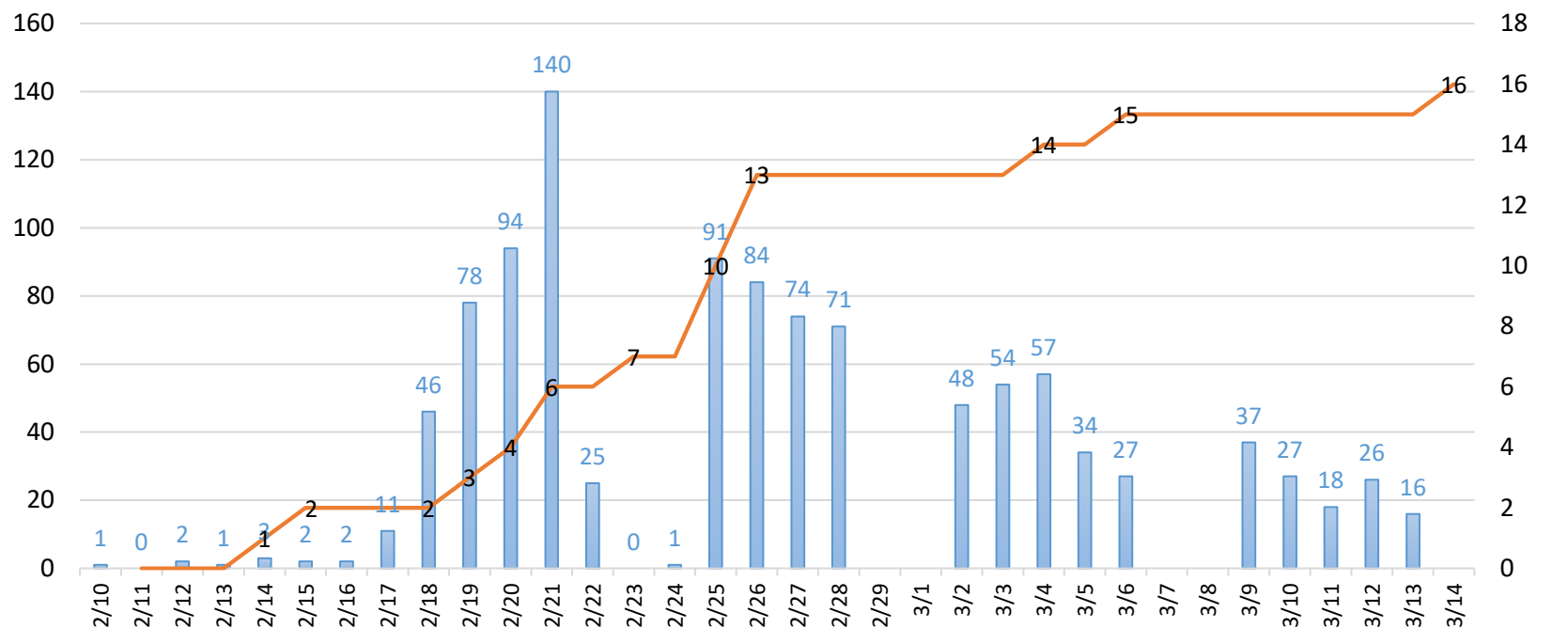
外線電話は7台（コードレス機が充電切れ）

熱田区

「新型コロナウイルス感染症患者累積数」及び「市民からの相談件数」

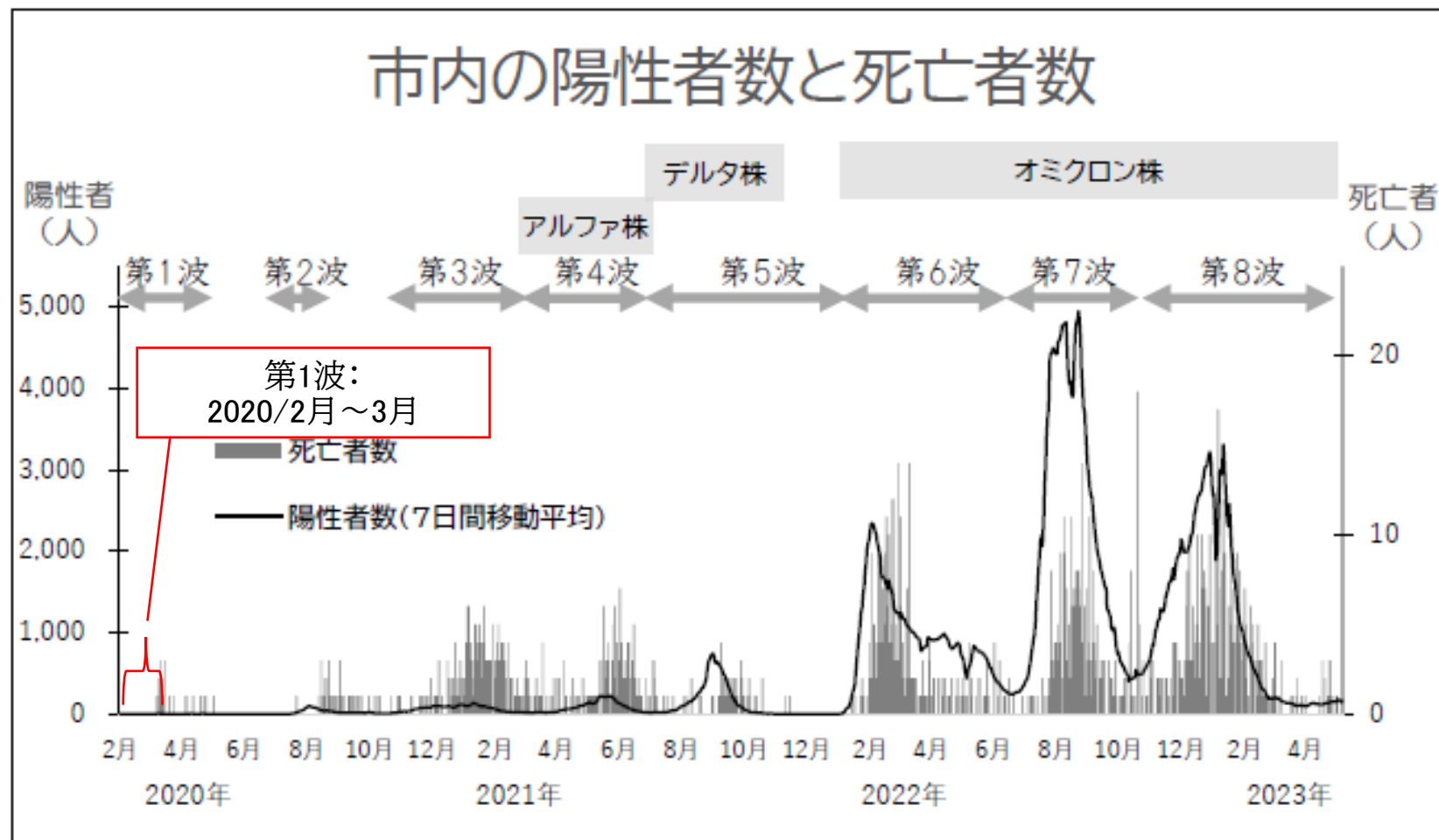
市民からの相談件数(件)

患者累積数(件)



■「熱田区」相談件数 —「熱田区」新型コロナウイルス感染症患者累積数

これだけ大変でも、患者はちょっぴり
(グラフ実線)



このころ（2020年）の世相①

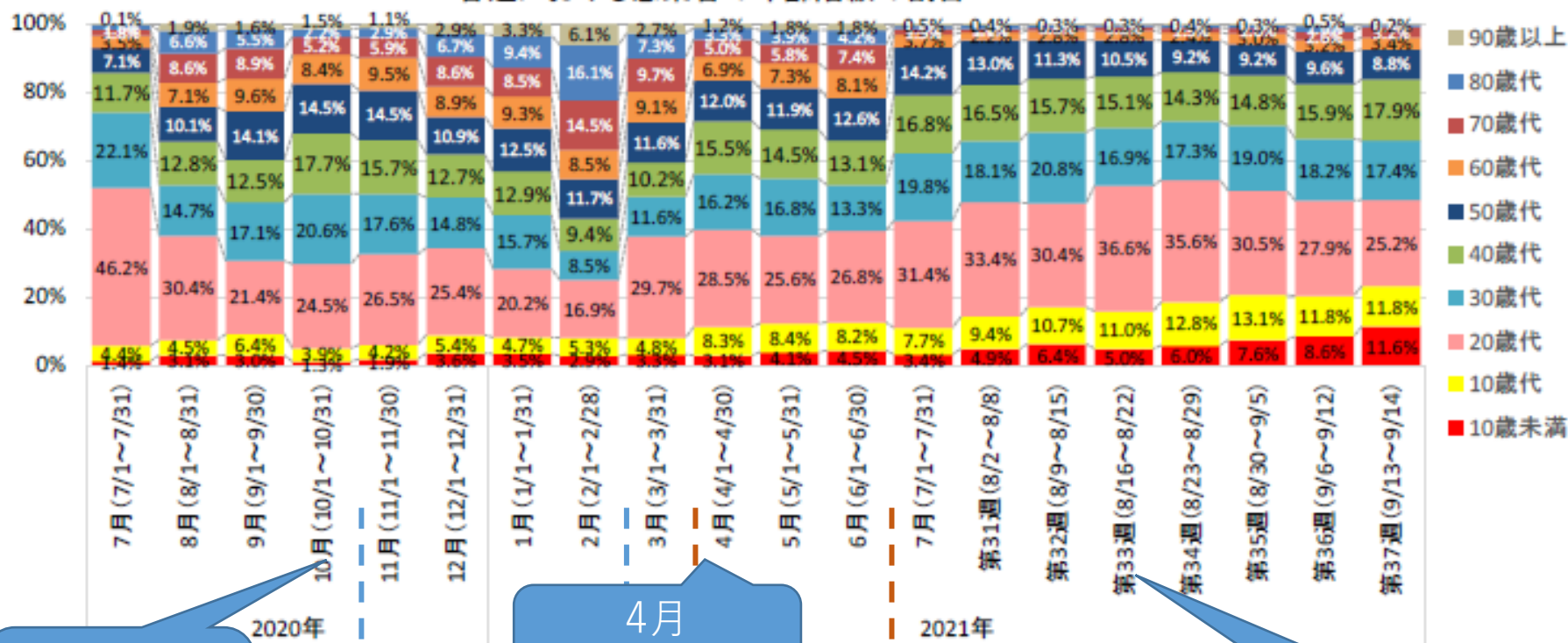
- 国民的な「検査の要請」
 - 「日本の患者数が少なめなのは検査が少ないから」論
- 医療機関からの検査要請に対応する（断る）仕事
 - 大規模な検査体制確立後まで断り続けた
 - 本来行政検査は、検査医療機関で通常行われない検査を行う
 - 確定診断のために行われる検査
 - 除外診断のために行われる検査ではない
（検査前確率の高い症例以外持ってこないでください）
- 市民対応（投書とか来庁者）は減ったが、相変わらず続く
 - 「**ぼくのかんがえたさいきょうのかんせんたいさく(°▽°)**」
 - 「偉い人が宴会をやっているのになんで一般国民ばかりガマンを強いるのか」クレーム

このころ（2020年）の世相②

- 病床が足りない！（患者は悪化しない限り**自宅待機**）
 - 保健センターが電話で患者の状況を把握し続ける
→悪くなったら入院
- 「入院勧告」との整合性は？
 - 入院すると食事が出るのに、自宅待機だと買い物にも行けない…
 - 保健センターがホテル入所、食事宅配
- 自宅待機者に民間の入院保険適用
 - 利益誘導してでも患者を炙り出して、患者の早期発見を促したい
 - 早期発見で対応できないほど患者数が増えたと
非常事態宣言やまん延防止措置（インフル特措法）で人流を止める
- 届出患者数が多すぎて、流行が来る度に
「届出受けた保健センターからの患者アクセスが翌日」
→**患者「いつになったら電話がくるんだ！（#`皿´）」**

2020年後半（第5波） ～2021年（第6、第7波） 年齢層別患者

各週における感染者の年齢階級の割合



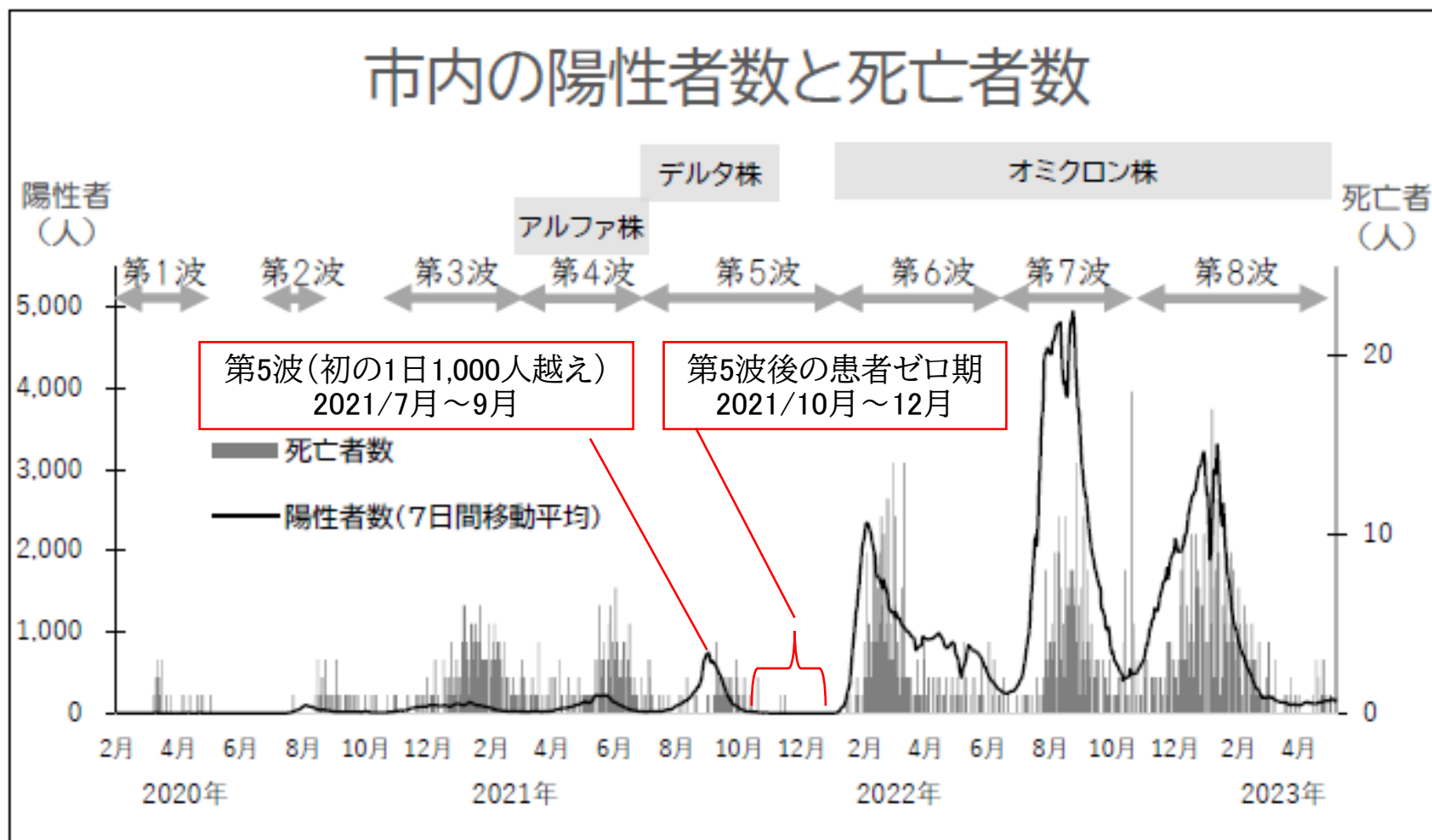
～2020年：
高齢者の
病気

4月
ワクチン開始

2021年
中年の病気に
*ICUは中年が
占拠



2021年以降



第4波（2021年4月頃）

- 2021年4月、有史以来の「一斉集団ワクチン接種」開始
 - 「ワクチンは人数分ある、でも一斉には供給されない」
 - 高齢者から順番に接種開始
 - ついでに医療従事者も優先接種
 - 名古屋市保健所・保健センター職員は接触者のPCR検査を行っていたため、優先接種対応
 - 市外の保健所は検査しないところが多く、
「保健所職員が検査をやっているから優先接種対象者」だと
なかなか理解されなかった
- 市民「**ワクチン予約電話がつかない！！（#`皿´）**
（保健センター、二度目の電話回線パンク）
- 市保健センターは患者対応と感染拡大防止の業務を担っているため、各区のワクチン業務は行っていない…ことが理解されない
- 市民「**なんで保健センターのくせにコロナワクチンの仕事やらないんだ！（#`皿´）**」

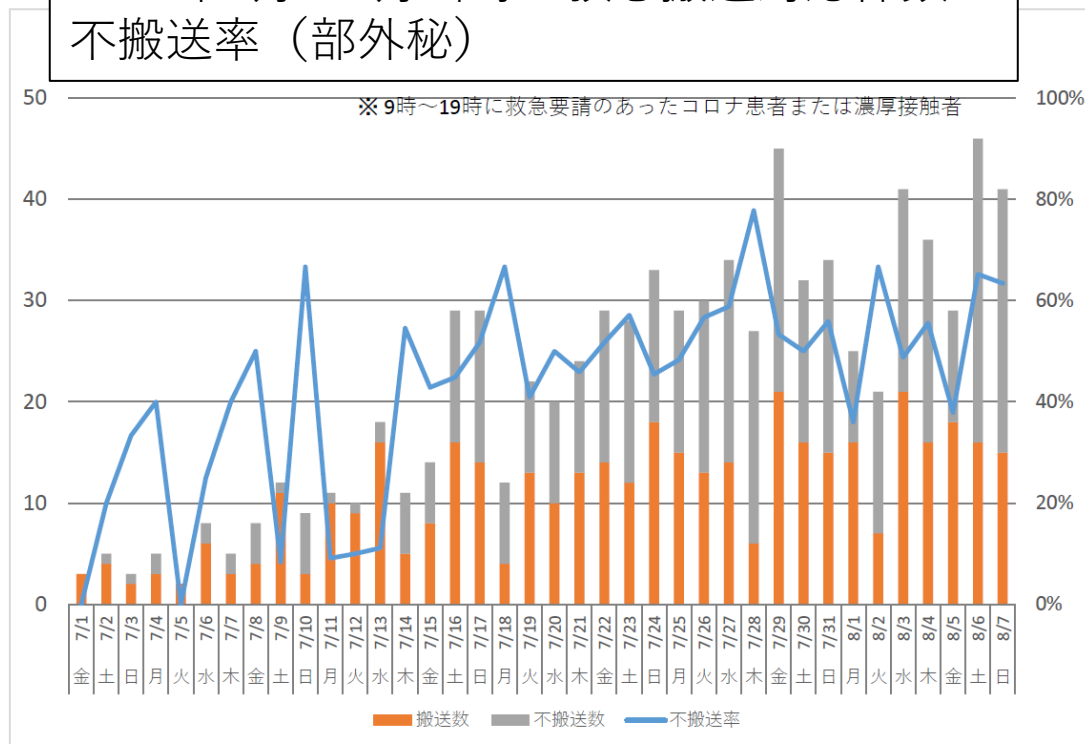
第5波（2021年8月頃）

- 初めての「新規患者数1日1,000人越え」
- 特定の医療機関に患者が集中、そこが大量の患者発生届を書く（ファックスする）羽目に
（書くのも一苦労、ファックスするのも一苦労）
 - 診断→保健所アクセスまでのタイムラグに、
診断→ファックス受領のタイムラグが加わる
 - オンライン発生届を整備
- **（名東区）** 初診医療機関の開拓
 - 患者を診断すると、同居家族が漏れなく感染して新規患者になる
 - 一般医療機関が本格的に参入する切っ掛けになった
- **（名東区）** コロナ患者が必要な情報（隔離期間、接触者の定義）に自力アクセスできるよう、医療機関に市ウェブサイト上の案内ページQRコードを送る

第6波（2022年）以降

- 爆発的な患者増（オミクロン株）
- 保健所は届出受領から、患者へのアクセスまで
2日以上かかることも
- 病院受診も優先度制（市本部一括管理）
 - 病床が足りない！（搬送先がない！）
- 病像の変化
（以前）ウイルス性肺炎→
（当時）ADL低下&誤嚥性肺炎
- 一般医療機関の出番が増えた…というか**本格参入**
- 在宅患者医療保険適用は続いたが「ロックダウン」はされなかった

2022年7月～8月当時の救急搬送対応件数と不搬送率（部外秘）



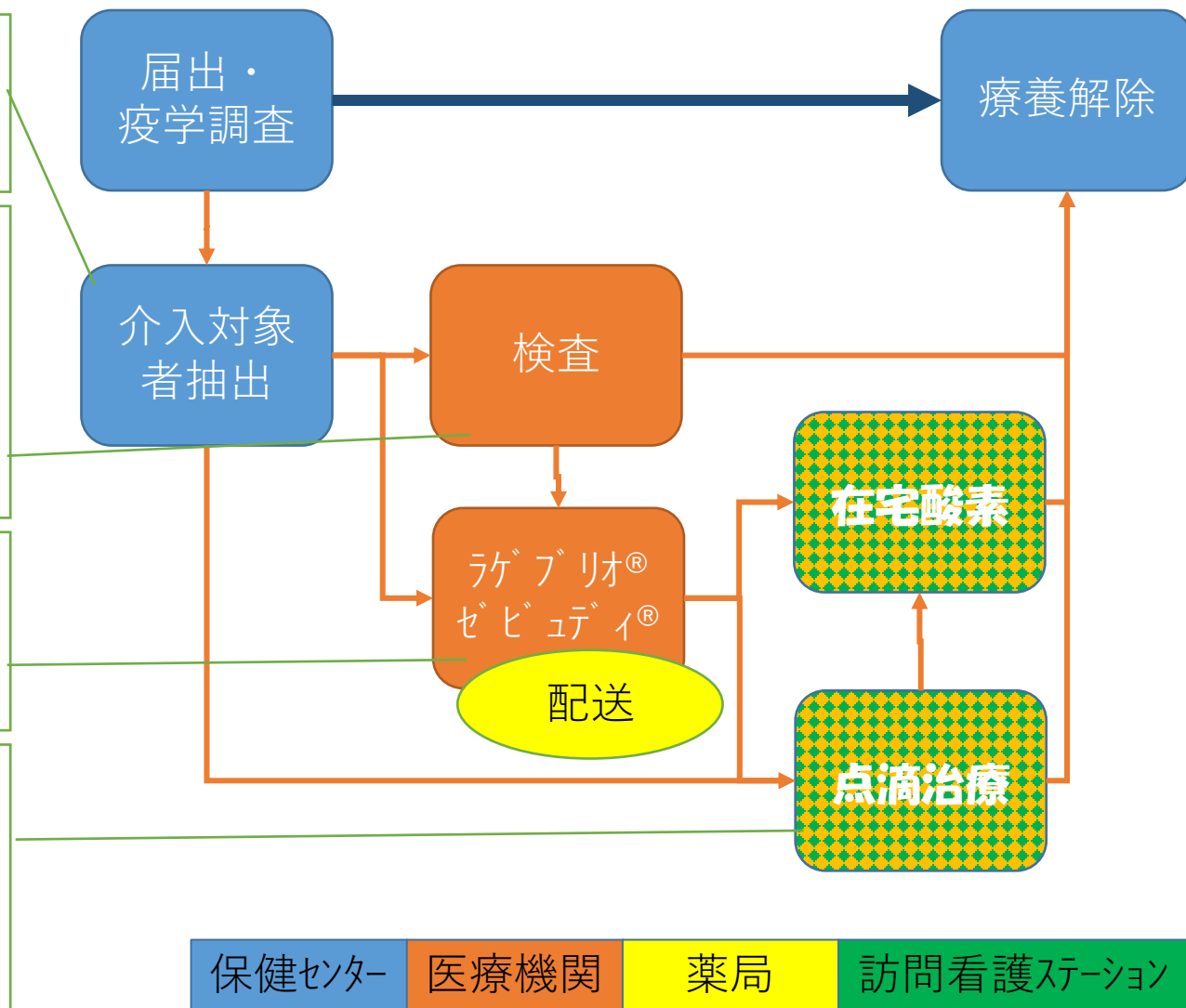
入院できないから在宅医療

全身状態が悪化した患者を保健センターが抽出

医療機関受診、検査(画像、血液)後、帰宅。その後は**オンライン診療**にて隔離期間中健康観察と有害事象観察

薬局は薬剤を自宅配送。
(ラゲブリオ[®]等治療薬のほか、解熱剤等)

在宅酸素療法、自宅での点滴療法のため、医療機関は**訪問看護ステーション(輪番制)**に指示。



つまり

- 地域診療 **（つながる医師！）**
- 薬剤配送 **（飛んでくる薬剤師！）**
- 訪問看護 **（駆けつける看護師！）**

・・・という、

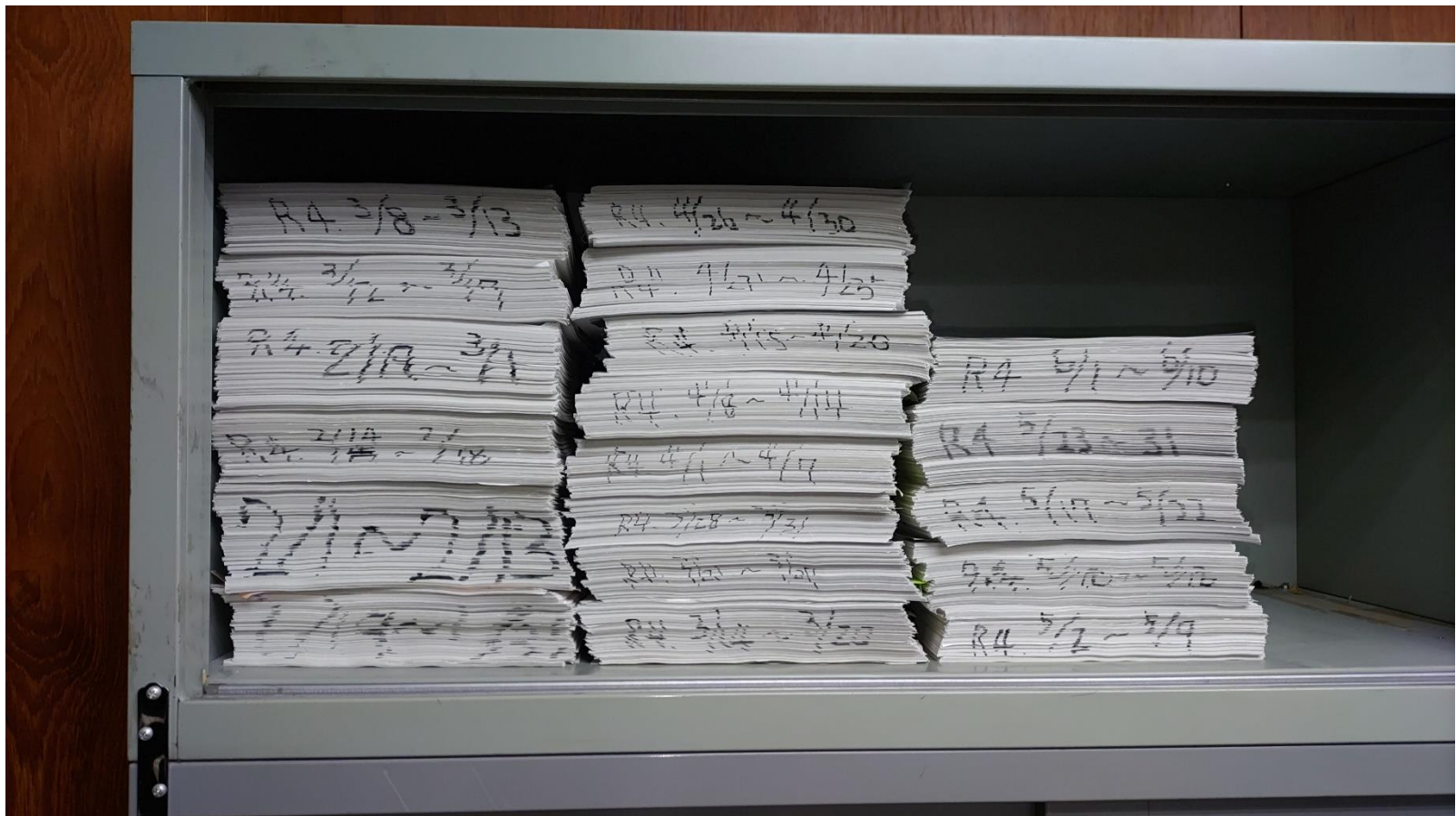
保健センター・医療機関・薬局・

訪問看護ステーションの相互連携を確立



駆けつけさせるために

- 診断医に電話診療での継続チェックを要請。
診察結果をファックスさせて、所見に問題がないか全チェック
(最大、1日200枚以上)



2023年5月8日、コロナ5類化
(名東HC所長時代)



- 保健所入院調整終了、診療所医師が自力で病院を探す体制に
- 名東区内病院「どこがまず、入院を受けるか」を整理

今日のエッセンス

- 危機管理(災害、感染症)
 - **M4学生「なんだか大変なんだなぁ(・ω・)」**
 - 大事の時は、どうやって周囲と**協働**するかが勝負
- 災害は連携
 - 会議をしないと有機的に動かない
- 保健所と保健センターの違い
 - 保健所：**県**にひとつの**厳しい**ところ
 - 保健センター：**村**にひとつの**優しい**ところ
- 人権制限系の仕事(入院勧告、措置入院)は**都道府県知事**担当
 - **選挙**で審判を受ける立場である
- 人権制限系入院の(当初)期間は72時間
 - **土日**を挟んで次の**役所開庁日**に、
入院が適切かを検討する会議を開くため

最後に：医師ってナニよ？

医師法

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

→ 少なくともルール上は

「公衆衛生向上活動をする」
ことが医師の存在目的